Samedi 20: Choc Septique

Cas Clinique : Histoire Clinique

Présentation initiale à l'admission

- **Patient :** Homme de 53 ans, admis aux urgences de l'EFR de l'Hôpital Béni-Messous.
- **Motif d'admission :** Fièvre, asthénie majeure, dyspnée ayant débuté 2 jours auparavant, d'aggravation progressive avec toux grasse.
- **Antécédents & Mode de vie :**
    - Diabétique non insulino-dépendant (DNID) traité par Glucophage (metformine) 850 mg matin et soir et Insulatard (LP) 10 UI le soir.
    - Jamais hospitalisé auparavant, vit avec sa femme et 3 enfants.
    - Ne consulte presque jamais et n'a pas vu son médecin traitant depuis 6 mois.
- **Histoire récente :** Consommation excessive depuis 3 jours de paracétamol 1000 mg (environ 4 à 5 prises par jour) en raison de la fièvre et d'une douleur thoracique gauche « en coup de poignard ».
- **Constantes initiales :**
    - Température : 39,6 °C
    - Pression artérielle : PAS 120 mmHg / PAD 60 mmHg
    - Fréquence cardiaque (FC) : 135 bpm
    - Fréquence respiratoire (FR) : 35 cycles/min
    - Saturation en O_2 (SpO2) : 87 % en air ambiant
- **Prise en charge immédiate :** Patient en sueur mis sous oxygène au masque à haute concentration.

Évolution à 30 minutes

- Le médecin est contacté par le résident de l'EFR.
- **Examen clinique :**
    - **Neurologique :** Patient confus et somnolent.
    - **Respiratoire :** Dyspnée évidente (FR : 40 cycles/min), cyanose intense, SpO2 à 88 % sous oxygène. Auscultation : râles crépitants de la base gauche avec un petit souffle tubaire.
    - **Hémodynamique :** Tachycardie régulière à 140 bpm, PAS 95 mmHg, PAD 50 mmHg, marbrures aux genoux.
    - **Cardiovasculaire :** Examen du cœur et des vaisseaux sans autre anomalie, aucun souffle cardiaque.

Questions et Réponses

Question 01

Concernant l'évaluation du patient selon les nouveaux critères de détection du sepsis « quick SOFA » :

- A. Un foyer infectieux pulmonaire est fortement probable
- B. Le patient présente une hypotension artérielle
- C. Le patient présente un état de choc septique
- D. Le patient présente une polypnée
- E. Le patient présente une confusion mentale

Rappel du cours (Slide 03) :

Le QUICK SOFA (qSOFA) :
Critères simplifiés utilisables hors réanimation pour le dépistage de patients pouvant présenter un sepsis :

1. Pression artérielle systolique le 100 mmHg
2. Fréquence respiratoire > 22 c/min
3. Confusion (score de Glasgow < 15

Commentaires / Justifications (Slide 05 & 06) :

- **A :** L'existence d'un foyer infectieux est indispensable pour définir le sepsis.
- **B :** La PAS est à 95 mmHg, donc < 100 mmHg comme requis dans la définition du quick sepsis (critère présent).
- **C :** Le choc septique est défini par la nécessité de recourir à des traitements vasopresseurs. C'est la forme la plus grave de sepsis. *(Non défini par le qSOFA seul).*
- **D :** La FR est à 40/min, soit > 22 c/min comme requis dans la définition du quick sepsis (critère présent).
- **E :** Le patient présente soudainement des signes de confusion mentale : troisième critère de la définition du quick sepsis (critère présent).

Question 02

Quels sont les signes de gravité de cette insuffisance respiratoire aiguë ?

- A. Polypnée à 45/min
- B. Cyanose intense
- C. Confusion (atteinte neurologique)
- D. État de choc (hypotension à 95/60 mm Hg chez un hypertendu)
- E. Tachycardie à 140/min

Question 03

Parmi les hypothèses diagnostiques, vous pouvez retenir pour expliquer la dyspnée :

- A. Une embolie pulmonaire
- B. Un pneumothorax
- C. Une pneumopathie communautaire aiguë grave
- D. Une pneumopathie nosocomiale
- E. Un œdème aigu du poumon

Justifications (Slide 10) :

- **A :** L'existence d'un syndrome infectieux, d'un foyer pulmonaire auscultatoire, et l'absence de signes d'insuffisance cardiaque droite et de phlébite ne sont pas en faveur.
- **B :** L'auscultation pulmonaire élimine un pneumothorax ; pour engendrer un tel retentissement hémodynamique, il devrait être suffocant/majeur avec des signes droits.
- **C : Retenue (typique).** Le patient n'a pas été hospitalisé récemment et n'a pas reçu d'antibiothérapie récente.
- **D :** Faux, ce n'est ni une pneumopathie nosocomiale ni associée aux soins.
- **E :** L'OAP est une forme clinique d'insuffisance cardiaque gauche et est exceptionnellement unilatéral. L'examen élimine donc ce diagnostic.

Évolution clinique ultérieure (Slide 11)

- Une heure après l'arrivée, le patient est sous masque à haute concentration, a reçu une perfusion de 500 ml de G5% avec 2 g de NaCl, et une radiographie pulmonaire en urgence a été prescrite.
- 30 minutes après la réalisation de la radio, aggravation clinique brutale :
    - PAS : 60 mmHg / PAD : 35 mmHg
    - FC : 135 bpm
    - FR : 40 cycles/min
    - SpO2 : 65 %

- Somnolence et extension des marbrures.

Question 04

À ce stade, quelle(s) est(sont) votre(os) première(s) décision(s) ?

- A. Vous demandez un scanner thoracique en urgence
- B. Vous décidez d'un transfert en réanimation
- C. Vous remplissez avec 30 ml/kg de SSI 9 ‰
- D. Vous réalisez une intubation orotrachéale et mettez en place une ventilation mécanique
- E. Vous laissez votre patient aux urgences et continuez la surveillance

Justifications (Slide 13) :

- **A (Faux) :** Le patient est très instable sur le plan hémodynamique et respiratoire, ce qui rend le scanner dangereux. À ce stade, il n'apporterait rien de décisif.
- **B (Vrai) :** Les recommandations internationales indiquent que les patients présentant un sepsis grave/choc doivent être admis le plus rapidement possible en réanimation.
- **C (Vrai) :** Devant tout sepsis/choc selon les recommandations, ce bolus de remplissage doit être administré au plus vite et éventuellement répété sous contrôle de la volémie jusqu'à stabilisation.
- **D (Vrai) :** L'intubation s'impose devant les troubles de conscience, les troubles hémodynamiques et la sévérité de l'insuffisance respiratoire.
- **E (Faux) :** Non, le patient doit obligatoirement être transféré en réanimation.

Question 05

Quels examens complémentaires simples demandez-vous pour préciser la cause de ce tableau ?

- A. Hémocultures
- B. Examen des crachats ????
- C. PCR multiplex
- D. Antigénurie pneumococcique
- E. Antigénurie légionnelle

Question 06

Quelle(s) est(sont) la(es) erreur(s) de la prise en charge initiale ?

- A. Avoir réalisé une radiographie thoracique en urgence
- B. Ne pas avoir introduit d'antibiotique
- C. Ne pas avoir débuté de remplissage vasculaire
- D. Absence de mise en place de voie veineuse centrale
- E. Avoir placé le patient sous oxygène au masque
- F. Ne pas avoir mis en place une épuration extra-rénale

Justifications (Slide 17) :

- **A (Pas une erreur) :** La radiographie contribue à asseoir le diagnostic de pneumopathie infectieuse.
- **B (Erreur) :** Les recommandations indiquent que tout patient en sepsis doit recevoir sans délai une première dose d'antibiothérapie probabiliste.
- **C (Erreur) :** Le remplissage vasculaire devait être débuté au plus vite.
- **D (Pas une erreur) :** Le remplissage peut très bien être réalisé sur une voie veineuse périphérique (VVP) ; poser une voie centrale d'emblée ferait perdre un temps précieux voire dangereux.
- **E (Pas une erreur) :** L'oxygénothérapie fait partie intégrante du traitement de toute détresse respiratoire et du sepsis.
- **F (Pas une erreur) :** Le patient ne présente aucun critère d'indication urgente d'épuration extra-rénale (pas d'OAP anurique, pas d'hyperkaliémie menaçante, pas d'acidose métabolique sévère avec pH < 7,15, urée > 40, oligo-anurie trop précoce pour trancher).

Question 07

Vous décidez de mettre une antibiothérapie. Quelle(s) molécule(s) choisir ?

- A. Imipenème seul
- B. Imipenème + Amikacine
- C. Céfotaxime + Ciprofloxacine
- D. Ceftriaxone + Lévofloxacine
- E. Tigécycline

Référence / Recommandations (Slides 19 & 20) :

- **Option retenue : D (Ceftriaxone + Lévofloxacine)** *(l'option C avec Ciprofloxacine est erronée car la ciprofloxacine n'est pas un fluoroquinolone à visée anti-pneumococcique)*.
- **Rappel thérapeutique pour les infections pulmonaires communautaires graves :**
    - Amoxicilline-acide clavulanique (2 g/8 h) **OU** Céfotaxime (2 g/8 h) **OU** Ceftriaxone (2 g/j)
      + Érythromycine (1 g/8 h) **OU** Ofloxacine (200 mg x 2 ou 3) **OU** Lévofloxacine (500 mg x 2).

- *En cas d'allergie prouvée aux pénicillines et C3G :* Glycopeptides + Ofloxacine ou Lévofloxacine.
- *Si risque de Pseudomonas aeruginosa (antibiothérapie fréquente, DDB, corticothérapie au long cours) :* Bêta-lactamines anti-Pseudomonas + Ciprofloxacine.